

INFECCIONES HERPÉTICAS

María Herrero Moyano, Leticia Calzado Villarreal, Paula Molina Ávila.

1. VIRUS HERPES SIMPLE (VHS1 Y VHS2)

Introducción

La infección por virus de herpes simple (VHS) tiene una alta prevalencia; hasta un 80% de la población tiene anticuerpos específicos. Existen dos subtipos, el VHS 1, que produce la mayoría de infecciones extragenitales y un 20% de las genitales, y el VHS 2 que produce la mayoría de infecciones genitales y algunas extragenitales.

Clínica

El cuadro de primoinfección aparece a los 3-7 días tras la exposición. Puede ir acompañado de sintomatología general como fiebre, adenopatías y malestar junto con las lesiones cutáneas típicas: vesículas dolorosas agrupadas sobre base eritematosa que después dan lugar a erosiones y costras. En niños, la primoinfección orofacial puede dar lugar a un cuadro de gingivoestomatitis llamativa. Sin embargo, la mayoría de primoinfecciones orofaciales son asintomáticas, al contrario que las genitales, que suelen dar lugar a cuadros de vulvovaginitis o balanopostitis dolorosas. Tras la primoinfección, el virus queda en fase de latencia en los ganglios de las raíces dorsales y puede reactivarse en situaciones de estrés, fiebre, inmunodepresión, cirugías o traumatismos locales, exposición UV, etc.

Otras formas clínicas menos frecuentes: panadizo herpético, herpes gladiatorum, eccema herpeticum (erupción variceliforme de Kaposi), úlceras profundas de curso crónico en inmunodeprimidos. También formas extracutáneas: herpes ocular, encefalitis herpética, proctitis y el herpes neonatal.

Diagnóstico

En muchas ocasiones el diagnóstico clínico es suficiente. Para una confirmación diagnóstica la prueba más sensible es una PCR. Si se requiere un diagnóstico rápido se puede realizar un **citodiagnóstico de Tzanck**, aunque esta prueba es menos sensible.

Tratamiento

En pacientes inmunocompetentes:

• Primoinfección:

- **Aciclovir 200 mg:** 200 mg cinco veces al día durante 7 a 10 días vía oral. Si se producen complicaciones neurológicas, 5 mg/kg por vía intravenosa cada 8 horas durante 5 días.
- **Valaciclovir 500 mg:** 1 g cada 12 horas durante 7-10 días vía oral.
- **Famciclovir 250 mg:** 250 mg cada 8 horas durante 7-10 días vía oral.

• **Recidivas:** las formas leves pueden manejarse únicamente con fomentos antisépticos (como sulfato de zinc) dos veces al día. Las formas más severas requieren tratamiento oral:

- **Aciclovir 200 mg:** 200 mg cinco veces al día durante 5 días vía oral, 400 mg tres veces al día durante 5 días vía oral u 800 mg tres veces al día durante 2 días vía oral.
- **Valaciclovir 500 mg:** 500 mg cada 12 horas durante 3 días vía oral o 1 g cada 24 horas durante 5 días vía oral.
- **Famciclovir 125 mg:** 125mg cada 12 horas durante 5 días vía oral o 1 g dos veces al día durante 1 día vía oral.

En pacientes inmunodeprimidos:

• Primoinfección:

- **Aciclovir 200 mg:** 400 mg cinco veces al día vía oral o 5- 10 mg/kg cada 8 horas vía intravenosa hasta la curación de las heridas.
- **Recidivas:**
 - **Aciclovir 200 mg:** 400 mg tres veces al día durante 5-10 días vía oral.

2. VIRUS VARICELA ZÓSTER (HHV-3)

Este virus tiene dos manifestaciones clínicas: **la primoinfección**, que produce la varicela, y **la reactivación**, que origina el herpes zóster.

2.1. VARICELA

Introducción

Se trata de una infección de distribución mundial que afecta a niños menores de 10 años en el 90% de las ocasiones. Se contagia por vía respiratoria teniendo la máxima infectividad hasta una semana después del exantema.

El cuadro clínico transcurre en tres fases bien definidas:

- **Pródromos:** Fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y artralgias.
- **Exantema:** Comienza en polo cefálico con expansión hacia el tronco. Discurre en “oleadas” de máculas que se transforman en pápulas, vesículas umbilicadas y costras, por lo que se pueden encontrar múltiples lesiones en diferentes estadios. Pruriginoso.
- **Complicaciones:** raras en niños. La más frecuente es la sobreinfección bacteriana. En adultos la complicación típica es la neumonía. Otras: encefalitis, síndrome de Reye, ataxia cerebelosa aguda, hepatitis, glomerulonefritis, neuritis óptica.

Diagnóstico

Mediante PCR del líquido de una vesícula.

Tratamiento

- **Inmunocompetentes:**
 - **Niños:** sólo se realiza tratamiento sintomático: antihistamínicos, antipiréticos (evitar AAS por posible síndrome de Reye) y soluciones antisépticas.
 - **Adultos:** Aciclovir 800mg 5 veces al día, durante 7 días.
- **Inmunodeprimidos:**
 - **Aciclovir:** 10 mg/kg i.v. ajustar según la función renal, cada 8 horas, durante 10 días.



Herpes zóster extenso (C3-C7) mostrando lesiones típicas (vesículas y costras sobre base eritematoedematosa de distribución metamérica).



Lesiones cutáneas típicas de varicela: vesículas que tienden a umbilicarse, sobre base eritematosa.

2.2. HERPES ZÓSTER

Introducción

La reactivación a nivel local del virus de la varicela ocurre en dos fases:

- **Pródromos:** dolor y parestesias en el dermatomo afectado.
- **Erupción herpética** (pápulas o placa eritematosa sobre las que aparecen las vesículas agrupadas) afectando un dermatomo, unilateral, sin atravesar línea media.
- **Complicaciones:**
 - **Neuralgia postherpética:** aparece en un 10-20% de los casos, aumentando la incidencia con la edad.
 - **Diseminación:** puede ocurrir en un 10% de los pacientes inmunodeprimidos.
 - **Mucho más raro:** meningoencefalitis, neumonitis... (inmunodeprimidos).
 - **La infección** por varicela en las primeras 20 semanas de gestación se asocia con un riesgo del 2% del síndrome de varicela congénita en el feto.

Cuadros clínicos particulares:

- **Herpes zóster oftálmico (V1):** en un 30-40% hay afectación de la rama nasociliar, con lesiones herpéticas en punta nasal (signo de Hutchinson) y afectación del globo ocular.
- **Síndrome de Ramsay-Hunt (VII par craneal):** parálisis facial, otalgia y lesiones herpéticas en concha auricular o conducto auditivo externo.
- **Herpes zóster sacro (S2-S3):** puede acompañarse de cistitis o retención aguda de orina.

Diagnóstico

PCR del líquido de una vesícula.

Tratamiento:

- **Sintomático:** en fase vesiculosa/erosiva se aplican fomentos de sulfato de zinc 1/1000 en solución acuosa cada 12 horas, mientras que en fase de costra se pueden aplicar pomadas antibióticas o vaselina pura.
- **Antiviral:** sobre todo cuando se inicia en las primeras 72 horas, reduce la severidad y la duración de las lesiones cutáneas y de la neuralgia postherpética.
 - **Aciclovir:** 800 mg cinco veces al día durante 7 días.
 - **Famciclovir:** 500 mg/8 horas durante 7 días.
 - **Valaciclovir:** 1 g/8 h durante 7 días.
 - **Pacientes inmunodeprimidos e infección diseminada:** 10 mg/kg de peso cada 8 horas durante 7-10 días en infusión lenta (1 hora) (ajustar para insuficiencia renal)
- **Tratamiento de la neuralgia postherpética:** Opiáceos, gabapentina y pregabalina, antidepresivos tricíclicos, crema de capsaicina, bloqueo nevioso.

3. PITIRIASIS ROSADA DE GIBERT

Introducción

Erupción eritematodescamativa aguda y autolimitada que aparece sobre todo en pacientes jóvenes. Su etiología es incierta, aunque se ha asociado al herpes virus tipo 6 y 7.

Clínicamente cursa en dos fases:

- **Aparición de la «placa heráldica»** (una placa rosa-anaranjada ovalada de 2 a 5 cm, con collarite descamativo, generalmente en el tronco) que antecede en 1-2 semanas a la aparición del exantema. En ocasiones se acompaña de cuadro pseudogripal.

- **Múltiples pápulas y placas ovals** de la misma coloración, distribuidas en el tronco y las raíces de los miembros de forma característica, «en árbol de navidad». El tiempo medio de resolución del cuadro es de 6 a 8 semanas.

Diagnóstico

- El diagnóstico es clínico.
- Diagnóstico diferencial: sífilis secundaria, psoriasis en gotas.

Tratamiento

No precisa al tratarse de un cuadro autolimitado y generalmente asintomático. Si presenta prurito puede tratarse con antihistamínicos orales y lociones calmantes (mentol, calamina) y/o corticoides tópicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Downing C, Mendoza N, Sra K, Tying SK. Human herpesviruses, in Bologna JL, Schaffer JV, Cerroni L (eds): Dermatology, 4th ed. New York: Elsevier; 2018: 1400-1421.
- Wood GS, Reizner GT. Other papulosquamous disorders. In: Bologna JL, et al. Dermatology. , 4th ed. New York: Elsevier; 2018:170-2.
- Fitzpatrick J, High W. Urgent Care Dermatology: Symptom-Based Diagnosis 1st Edition. Elsevier 2017.
- Rodríguez-Jiménez P, Estébanez Corrales A, Molina Ruiz AM, et al. Manual de dermatología para residentes, 2ª ed. Barcelona: Editorial glosa; 2019.